おのまち障がい者計画

第４期障がい児福祉計画

第８期障がい福祉計画

素案（第３版）

計画期間：令和９年度～令和11年度

令和８年10月

小　野　町

目　次

各行をクリックすると本文へ移動します。ページ番号は Word で開いた時点で更新されます

第１部　総論……2
第１章　計画策定にあたって……2
第２章　障がいのある人を取り巻く状況……9
第３章　現行計画の評価と課題……12
第２部　おのまち障がい者計画……16
第１章　基本的な考え方……17
第２章　差別解消・権利擁護の推進……18
第３章　安全・安心な生活環境の整備……19
第４章　情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実……20
第５章　防犯・防災の推進……21
第６章　保健・医療の充実……22
第７章　自立生活支援・相談支援体制の充実……24
第８章　教育の振興……26
第９章　雇用・就業、経済的自立の支援……27
第10章　文化芸術活動・スポーツ等の振興……28
第３部　第８期障がい福祉計画・第４期障がい児福祉計画……29
第１章　成果目標……29
第２章　活動指標・サービス見込量……31
第３章　見込量確保のための方策……34
第４部　計画の推進……35
１　推進体制……35
２　支援会議・支援協議会の相互連携……35
（参考）小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業（令和９年４月１日新設）……35
３　進行管理と評価……36
４　計画の周知……36
資料編……37
１　計画の策定経過……37
２　小野町自立支援協議会委員名簿……37
３　パブリックコメントの結果……37
４　用語の説明……37
５　関係法令……37

第１部　総論

第１章　計画策定にあたって

1　計画策定の趣旨

本町では、「おのまち障がい者基本計画・第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画」（令和６年３月）に基づき、障がいのある方への支援に取り組んできました。**同計画は令和８年度をもって計画期間が満了します。**

この間、国においては、**障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針**が改正され（令和８年３月31日告示）、**社会福祉法等の一部を改正する法律（令和８年法律第51号）**及び**医療的ケア児支援法の改正（令和８年法律第77号）**が成立しました。**いずれも令和９年４月１日に施行され、本計画の期間の初日に当たります。なお、この改正により同法の題名そのものが「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律」に改められます**（現行は「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」）。

本町においても、**令和７年４月に小野町手話言語及び障がい者コミュニケーション条例**を制定しました。

こうした状況を踏まえ、障がいの有無にかかわらず、誰もが地域で安心して暮らし続けられるまちを目指して、本計画を策定します。

2　計画の位置づけ

本計画は、次の３つの計画を一体のものとして策定するものです。

【表１】第１部第１章　計画策定にあたって

計画	根拠	内容
おのまち障がい者計画	障害者基本法第11条第３項	障がい者のための施策に関する**基本的な計画**。分野別の施策の方向を定める（第２部）
第８期障がい福祉計画	障害者総合支援法第88条第１項	障害福祉サービス等の**提供体制の確保**に関する計画。成果目標・活動指標・見込量を定める（第３部）
第４期障がい児福祉計画	児童福祉法第33条の20第１項	障害児通所支援等の**提供体制の確保**に関する計画（第３部）

障がい者計画は「何を目指すか」を、障がい福祉計画・障がい児福祉計画は「どれだけ確保するか」を定めるものです。 性格が異なるため、本計画では第２部と第３部に分けて記載し、**両者をつなぐ対応関係を第３部第１章に示します。**

本計画に定める法定の記載事項は、次のとおりです。

【表２】第１部第１章　計画策定にあたって（２）

根拠条項	記載事項	義務の強さ	本計画での箇所
障害者基本法第11条第３項	市町村障害者計画	**義務**	**第２部**（分野別施策）
障害者総合支援法第88条第１項	市町村障害福祉計画	**義務**	**第３部**（成果目標・活動指標・見込量）
児童福祉法第33条の20第１項	市町村障害児福祉計画	**義務**	**第３部**（同上）

障害者総合支援法第 88 条第 2 項第 1 号	障害福祉サービス等の必要な量の見込み	**義務**	第 3 部第 2 章
同第 88 条第 2 項第 2 号	見込量の確保のための方策	**義務**	第 3 部第 3 章
児童福祉法第 33 条の 20 第 2 項第 1 号	障害児通所支援等の必要な量の見込み	**義務**	第 3 部第 2 章 5
同第 33 条の 20 第 2 項第 2 号	見込量の確保のための方策	**義務**	第 3 部第 3 章
障害者総合支援法第 88 条第 3 項第 3 号	**生産性の向上・従事者の確保・安定した経営基盤**の双方の実現を図る取組に資する**都道府県と連携した取組**	努力（**新設**）	**第 3 部第 3 章 4**
同第 88 条第 3 項第 4 号	**地域生活支援事業に従事する者**の確保及び資質の向上に資する都道府県と連携した取組	努力（**新設**）	**第 3 部第 3 章 4**
同第 88 条第 3 項第 5 号	**地域生活支援事業の実施**における生産性の向上に資する都道府県と連携した取組	努力（**新設**）	**第 3 部第 3 章 4**
児童福祉法第 33 条の 20 第 3 項第 3 号	**障害児通所支援及び障害児相談支援**の提供における**生産性の向上・従事者の確保・安定した経営基盤**の双方の実現を図る取組に資する**都道府県と連携した取組**	努力（**新設**）	**第 3 部第 3 章 4**
障害者総合支援法第 88 条第 9 項 **児童福祉法第 33 条の 20 第 9 項**	**支援協議会**を設置したときは、計画を定め、又は変更しようとする場合に**あらかじめその意見を聴く**	努力（名称の改正）	**第 1 部第 1 章 5**
障害者総合支援法第 88 条第 7 項 **児童福祉法第 33 条の 20 第 7 項**	**市町村障害者計画（障害者基本法第 11 条第 3 項）・市町村地域福祉計画（社会福祉法第 107 条第 1 項）その他の計画と調和が保たれたもの**	**義務**	第 1 部第 1 章 2・4
障害者総合支援法第 88 条第 6 項・児童福祉法第 33 条の 20 第 6 項	市町村障害福祉計画と市町村障害児福祉計画を**一体のものとして作成することができる**	できる規定	第 1 部第 1 章 2

※ 令和 8 年法律第 51 号により新たに加わった記載事項には（新設）と記しています。いずれも「定めるよう努める」（努力義務）です。都道府県障害福祉計画では同じ事項が「定めるものとする」（義務）とされ、さらに目標の定めが加わるため、**本計画は県の計画と同じ構えにしていません。**資料：厚生労働省「社会福祉法等の一部を改正する法律案　新旧対照条文」。

3　計画期間

本計画の期間は、令和 9 年度から令和 11 年度までの 3 年間です。障がい福祉計画・障がい児福祉計画は 3 年を一期として定めるものとされています。

なお、おのまち障がい者計画についても、障がい福祉計画・障がい児福祉計画と一体で策定することから、同じ 3 年間とします。

【表 3】第 1 部第 1 章　計画策定にあたって（3）

年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度
本計画	策定	**初年度**	中間年	**最終年度**
現行計画	**最終年度**	—	—	—
高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画	策定	初年度	中間年	最終年度
第 5 次福島県障がい者計画	—	**最終年度**	**（次期計画）**	**（次期計画）**

※ 第５次福島県障がい者計画は令和９年度で計画期間が満了します。本計画期間の後半は、県の次期計画の策定状況を踏まえて整合を図ります（策定状況を県に照会中。【決定後に記載】）。

4　関連計画との関係

本計画と関連する計画は、次のとおりです。

【表４】第１部第１章　計画策定にあたって（4）

計画	期間	関係	役割分担
小野町第３期地域福祉計画	令和８～12年度	**上位計画**	地域共生社会、重層的支援体制、住民主体の見守り、生活困窮・ひきこもり、成年後見制度利用促進、一般的な防災・防犯。**本計画は障がい固有の課題に具体化する**
小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画	令和９～11年度	**関連計画（同時策定）**	**65歳到達時の介護保険への移行、高齢障がい者、共生型サービス。**人口推計の前提を統一する。**接点は第１部第１章4-2に一覧で示す**
小野町こども計画	—	関連計画	障がい児支援、療育、就学前後の支援、ヤングケアラー・きょうだい支援
小野町総合計画	町の最上位計画	関連計画	基本理念・まちづくりの方向
小野町地域公共交通計画	—	関連計画	移動支援、外出支援
小野町地域防災計画	—	関連計画	**避難行動要支援者名簿・個別避難計画。**医療的ケア児等支援センターの業務に個別避難計画の作成への協力が加わる（令和９年４月１日施行）
小野町手話言語及び障がい者コミュニケーション条例	令和７年４月	**町条例**	**第２部第４章の根拠。**手話の普及、多様な意思疎通支援
第５次福島県障がい者計画	**令和９年度で満了**	県計画	**本計画期間の後半は県の次期計画の策定状況を踏まえる**（照会中）
第８期福島県障がい福祉計画・第４期福島県障がい児福祉計画	令和９～11年度	県計画	**成果目標のうち県が設定するものとの整合**
福島県保健医療計画（第八次）	令和６～11年度	**県計画**	**本計画期間を包含する。**第８章第５節（にも包括）、第８章第11節（医療的ケア児への支援充実）、第９章第３節（難病対策）
福島県地域福祉支援計画	—	県計画	町の地域福祉計画の上位
福島県賃貸住宅供給促進計画・福島県住生活基本計画	—	県計画	**住宅確保要配慮者に障がいのある方が含まれる。**グループホームからの地域移行、単身生活への移行の受け皿

※ 本計画が求められる関係は２種類あります。 障害者総合支援法第88条第７項及び児童福祉法第33条の20第７項は、**市町村障害者計画（障害者基本法に基づくもの）等と調和が保たれたものでなければならない**としています。**「調和」であって「整合性の確保」ではありません。**高齢者計画の素案 第１章３でも同じ整理をしており、両計画で相手方と書き方をそろえています。**条項の番号は、現行条文（e-Gov 法令 API・令和８年10月19日取得）で確かめました。** いずれも全12項で、令和８年法律第51号による項の繰り下がりはありません。**第６項は、障害福祉計画と障害児福祉計画を一体のものとして作成することができるとしています。本計画はこれによります。**

4-2　高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画との接点

本町では、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画と、障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画を**同じ期間（令和９年度～令和11年度）で同時に策定**しています。

両制度の間には、同じ方が年齢や状態の変化によって行き来する場面があります。 どちらの制度がどちらに当たるかを決める手順を両計画で揃えておかないと、**同じ方の同じ利用が両方の見込量に入る**、

あるいは**どちらにも入らない**ということが起こります。なお、同じ方が両制度のサービスを併せて使うことはあり、その場合はそれぞれの計画に計上します。

本節は、その判定の手順と、判定に用いる言葉を定めるものです。**両計画に同じ内容を掲げています。**

【表５】第１部第１章　計画策定にあたって（５）

#	場面	制度の内容	本町での扱い
1	40 歳から 64 歳までの方（第２号被保険者）との重なり	第２号被保険者は 40 歳以上 65 歳未満の医療保険加入者です。介護保険の給付を受けるには、加齢に伴って生ずる**特定疾病**に起因して要介護・要支援の状態にあることが必要です。障がい福祉サービスを利用している方がこれに該当する場合、**65 歳未満でも介護保険が優先する場面があります。**	障がい福祉サービスの受給者のうち、特定疾病により要介護認定を受けている方の人数を、両計画で同じ数として扱います。
2	65 歳に達したときの判定と引継ぎ	65 歳に達した方は第１号被保険者になります。障がい福祉サービスから介護保険サービスへ移るかどうかは、**一律に決まるものではなく、個別に判定します。**	到達の年月・現に利用しているサービスと量・介護保険に相当するサービスの有無・受入れの可否・本人の意向を１件ずつ確かめ、**実際に移る分だけを両計画の見込量に同じ年度で反映します。**地域包括支援センターと相談支援事業所が同時に動きます。
3	介護保険優先原則を一律に適用しないこと	障害者総合支援法は、介護保険の給付が受けられる場合にはそちらを優先するとしていますが、**国の通知により、一律に適用するのではなく市町村が個別に判断する**こととされています。	**「65 歳になったので介護保険へ」という扱いはしません。** 下の４・５の判定を経て決めます。
4	介護保険に相当するサービスがないもの	**共同生活援助、施設入所支援、就労系のサービス、同行援護、行動援護などは、介護保険に相当するサービスがありません。** これらは 65 歳に達した後も障がい福祉サービスとして続きます。また、必要な量が介護保険の支給限度基準額で足りない場合は、**足りない部分を障がい福祉サービスで併せて用います。**	障がい計画の見込量から、これらを一律に減らすことはしません。介護保険計画の見込量にも、これらに当たる分を積みません。
5	介護保険の適用除外となる施設の入所者	**指定障害者支援施設に、生活介護と施設入所支援の両方の支給決定を受けて入所している方は、介護保険の被保険者となりません。**「施設入所支援を使っているか」ではなく、**どのような支給決定を受けているか**で決まります。	**該当する方は第１号被保険者数から除きます。** 第１号被保険者数は保険料の分母であり、認定率の分母でもあるため、該当する方がいる場合は保険料の算定に影響します。
6	共生型サービスと基準該当障害福祉サービスの区別	**この２つは別の仕組みです。** 共生型サービスは、一方の制度の指定を受けた事業所が**申請して**もう一方の制度の指定を受けるものです。基準該当障害福祉サービスは、通常の指定を受けていない事業所について**市町村が給付の対象とする**ものです。	**同じ事業所が両計画に現れます。** 事業所の数を数えるときは、事業所番号で名寄せし、どちらの指定によるものかを分けて書きます。
7	介護保険へ移った方の利用者負担の軽減	障がい福祉サービスを長く利用してきた方が介護保険へ移ったときに、利用者負担を軽減する給付があります。**対象となるサービスの種類は限られており、介護予防サービスは対象外です。**	**申請の窓口は介護保険の側です。** 障がい福祉の担当から介護保険の担当へつなぐ手順を定め、両計画に同じ内容を書きます。
8	計画相談支援から居宅介護支援への引継ぎ	介護保険へ移った方のケアマネジメントは**居宅介護支援**が担います。その方は計画相談支援の対象から外れます。	障がい計画の計画相談支援の見込量から移った分を減らし、介護保険計画の居宅介護支援の見込量に同じ分を加えます。**どちらか一方だけを動かすと、合計が合わなくなります。**

9	両計画で同じ方・同じ量を二重に数えないこと	上の１から８までは、いずれも**同じ方が両方の計画に現れうる**場面です。両計画がそれぞれに見込むと、**同じ方のサービスを二重に見込むことになります。**	**移る方の一覧を１つ作り、両計画がそこから引きます。** 一覧は、到達の年度・利用しているサービス・移る先・移る年度を持つものとします。
10	支援会議と支援協議会が互いに連携すること（**法定**）	令和８年法律第 51 号により、**介護保険法第 115 条の 48 第５項**と**障害者総合支援法第 89 条の３第５項**が新たに置かれました。介護保険法の**支援会議**（改正前は「会議」）と、障害者総合支援法の**支援協議会**（改正前は「協議会」）は、同じ地方公共団体にもう一方が置かれているときは、**相互に連携を図るよう努めなければならない**こととされます。**互いの名前が互いの条文に書かれており、双方向の規定です。**令和９年４月１日施行で、本計画期間の初日に当たります。**なお、条文が名指ししているのは２つではなく５つです。** 介護保険法第 115 条の 48 第５項は、障害者総合支援法第 89 条の３第１項の支援協議会のほか、**社会福祉法第 106 条の３の２第１項の支援会議、住宅セーフティネット法第 81 条第１項の支援協議会、生活困窮者自立支援法第９条第１項の支援会議**、その他支援体制の構築に資する会議を挙げています（障害者総合支援法第 89 条の３第５項も同じ構成です）。	**上の１から９までの判定を、これらの会議の連携の場で行います。** 介護保険法の支援会議は、実施の一部を地域包括支援センターの設置者に委託することができ（同条第６項）、運営に当たり包括的支援事業との連携を図ることその他地域の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとされます（同条第７項）。本町にどれが置かれているかを確かめたうえで、**どの場で、いつ、誰が判定するかを両計画に同じ内容で書きます。**

両計画の人口の前提をそろえます。高齢者計画は、保険料を国の推計ワークシートにより算定するため、国が配布する推計用人口を用いています（第２章６）。障がい計画はこれから人口の基礎を置くところであり、**高齢者計画と同じ系列を用います。**同じ町の２つの計画が同じ年の人口を違う数で載せることは避けます。

※ 10 に掲げた条項は、**e-Gov 法令 API（デジタル庁）により、令和９年４月１日時点に効力をもつ条文の現物で確かめたもの**です（令和８年 10 月 19 日取得）。令和９年４月１日は本計画期間の初日であり、**計画期間に適用される条文は改正後のものです。** 改正の本体は社会福祉法等の一部を改正する法律（令和８年法律第 51 号。公布 令和８年６月 25 日）です。1 から 9 までの制度の内容について、**根拠となる条項の番号は原典で確かめたうえで記載します。 介護保険法施行法・同法施行令・同法施行規則・障害者総合支援法施行令・同法施行規則も、同じ法令 API で取得できます。 ただし告示は法令 API の対象外です。** 7 の対象となるサービスの種類も、原典で確かめてから具体に書きます。

上の判定を行うために、次のことを町に確かめます。

【表６】第１部第１章　計画策定にあたって（6）

#	確かめること	効くもの
1	介護保険の適用除外に当たる方の有無（指定障害者支援施設に生活介護と施設入所支援の両方の支給決定を受けて入所している方）	5（保険料の分母）
2	令和９年度から令和 11 年度までに 65 歳に達する障がい福祉サービス利用者の一覧（到達年度・利用しているサービスと量・障害支援区分・市町村民税の課税状況）	2・4・7・9（両計画の見込量）
3	第２号被保険者の認定者のうち、障がい福祉サービスの受給者証をお持ちの方の人数と利用しているサービス	1（両計画の見込量）
4	町内事業所の事業所番号と指定の種類（共生型サービスの指定の有無、基準該当障害福祉サービスの有無）	6（事業所の数え方）
5	計画相談支援の実利用者数のうち、65 歳以上の方の人数	8（引継ぎ）

6	**障害者総合支援法第 89 条の３の支援協議会（自立支援協議会）と、介護保険法第 115 条の 48 の支援会議の設置の有無。**単独設置か田村地方での共同設置か、年間の開催回数と構成員	10（判定を行う場）
7	**社会福祉法第 106 条の３の２の支援会議、住宅セーフティネット法第 81 条第１項の居住支援協議会、生活困窮者自立支援法第９条第１項の支援会議の設置の有無。**改正後の介護保険法第 115 条の 48 第５項は、これらとの相互の連携も努力義務としているため、置かれている会議体を一覧にします	10（判定を行う場）

いずれも【町データ待ち】です。**２の一覧が得られれば、２・４・７・９がまとめて片付きます。**

本計画での箇所と、高齢者計画での箇所の対応は次のとおりです。

【表７】第１部第１章　計画策定にあたって（７）

接点	本計画での箇所	高齢者計画での箇所
65 歳到達時の介護保険への移行	第２部第７章６	高齢者計画 第４章４
共生型サービス	第３部第２章１・２	高齢者計画 第４章４
高齢障がい者の実態把握	第１部第２章５	高齢者計画 第２章３
支援会議と支援協議会の相互連携	**第１部第１章５**	**高齢者計画 第４章４**
地域生活支援拠点等と地域包括支援センター	第２部第７章２	高齢者計画 第４章４
重層的支援体制整備事業	第１部第１章４	高齢者計画 第１章３
人口推計の前提	第１部第２章１	高齢者計画 第２章１
医療的ケア児等への支援	第２部第６章３・第３部第１章⑧	高齢者計画 第５章 基本目標２⑦
災害時の個別避難計画	第２部第５章１	高齢者計画 第５章 基本目標２⑥
成年後見制度の利用促進	第２部第２章１	高齢者計画 第５章 基本目標２⑤

５　策定体制

本計画は、**小野町自立支援協議会**にお諮りしながら策定します。あわせて、庁内の関係課による検討を行い、**パブリックコメント**により町民の皆様のご意見を反映します。

障害者総合支援法第 88 条第９項及び児童福祉法第 33 条の 20 第９項は、支援協議会を設置したときは、計画を定め、又は変更しようとする場合に、あらかじめその意見を聴くよう努めなければならないとしています。令和８年法律第 51 号により、「協議会」が「支援協議会」に改められます（令和９年４月１日施行）。**本町の自立支援協議会がこれに当たるかを確かめたうえで、意見を聴く手続を経ます。**

【表８】第１部第１章　計画策定にあたって（８）

区分	内容
小野町自立支援協議会	開催回数・時期　【決定後に記載】
支援協議会への意見聴取（法第 88 条第９項・児福法第 33 条の 20 第９項）	時期　【決定後に記載】
令和８年度調査	アンケート調査・関係者団体等ヒアリング　【町データ待ち】
庁内検討	関係課による検討　【決定後に記載】
パブリックコメント	実施時期・期間　【決定後に記載】

6　計画の対象

本計画の対象は、**障がいのある方**（身体障がい・知的障がい・精神障がい・発達障がい・難病・高次脳機能障がい等のある方。手帳の所持の有無を問いません）及び**障がいのある子ども**です。

手帳をお持ちでない方も対象に含みます。難病や発達障がいのある方のなかには手帳をお持ちでない方が多くいらっしゃいます。本計画では、手帳所持者数を状況把握の中心に置きながらも、**手帳の有無で支援の対象を切らない**こととします。

7　計画の進行管理

本計画は、**PDCA サイクル**により進行管理を行います。毎年度、成果目標の達成状況と活動指標・サービス見込量の実績を把握し、小野町自立支援協議会に報告します。

障害者総合支援法第 88 条の 2 及び児童福祉法第 33 条の 20 の 2 は、市町村が、計画に定める事項について、定期的に調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは計画を変更することを求めています。

【表 9】第 1 部第 1 章　計画策定にあたって（9）

区分	時期	内容
実績の把握	毎年度	成果目標・活動指標・サービス見込量の実績
評価と報告	毎年度	小野町自立支援協議会への報告と意見聴取
中間の見直し	令和 10 年度	**国・県の計画の改定、法改正への対応**
次期計画の策定	令和 11 年度	調査の実施と次期計画の検討

第２章　障がいのある人を取り巻く状況

1　人口・世帯の状況

本町の人口推計は、高齢者保健福祉計画・第 10 期介護保険事業計画と前提を統一します。同時に策定している両計画で人口の見通しが食い違うことのないよう、出典を一つにします（【町データ待ち】）。

※ 高齢者計画は「第 10 期将来推計用推計人口」（町受領）を用いています。**本計画も同じ推計を用います。**

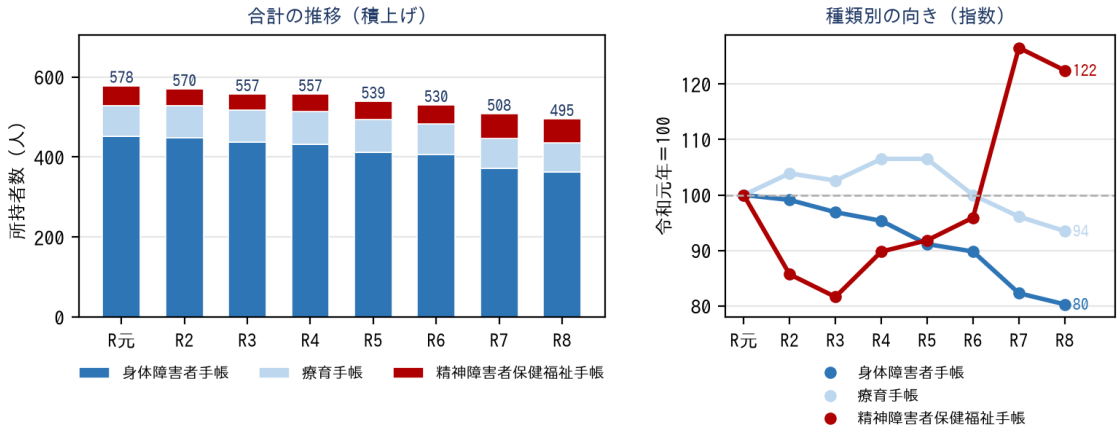
2　障がい者手帳所持者の状況と見通し

本町の障がい者手帳の所持者数の推移は、次のとおりです。

【表 10】第１部第２章　障がいのある人を取り巻く状況

手帳の種類	令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	令和８年
身体障害者手帳	452 人	448 人	438 人	431 人	412 人	406 人	372 人	363 人
療育手帳	77 人	80 人	79 人	82 人	82 人	77 人	74 人	72 人
精神障害者保健福祉手帳	49 人	42 人	40 人	44 人	45 人	47 人	62 人	60 人
合計	**578 人**	**570 人**	**557 人**	**557 人**	**539 人**	**530 人**	**508 人**	**495 人**

【図 1】第１部第２章２　障がい者手帳所持者数の推移



資料：令和元年～令和５年はおのまち障がい者基本計画（令和６年３月）、令和６年・令和８年は町の見込量・目標値設定シート、令和７年は町からの受領値（各年４月１日現在・健康福祉課）

資料：令和元年～令和５年は**おのまち障がい者基本計画・第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画（令和６年３月）**、令和６年・令和８年は町の見込量・目標値設定シート（令和８年９月）、令和７年は町からの受領値。いずれも**各年４月１日現在・健康福祉課**。※ 設定シートは基準日を記載していません。令和５年・令和７年の値が上の出典と一致するため、同じ４月１日現在とみなしています（【町データ待ち】）。

全体では、令和元年の 578 人から令和８年の 495 人へ、７年間で 83 人（14.4％）減っています。ただし、手帳の種類によって動きが逆です。

身体障害者手帳は 452 人から 363 人へ 89 人（19.7％）減り、全体の減少（83 人）を上回ります。療育手帳は 77 人から 72 人へ、おおむね横ばいです（令和４・５年の 82 人をピークに減っています）。**一方、精神障害者保健福祉手帳は 49 人から 60 人へ 11 人（22.4％）増えています。**とくに令和５年

の 45 人から令和 7 年の 62 人への増え方（37.8％）が大きく、令和 8 年も 60 人と、その水準を保っています。

減少の要因は【町データ待ち】です。人口減少によるものか、返還・死亡によるものか、新規の申請が減っているのかによって、本計画で手当てすべきことが変わります。

※ 等級別・年齢別の内訳、重複所持者数は【町データ待ち】です。**精神障害者保健福祉手帳の増加は、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム（第２部第６章１・第３部第１章②）を本計画で新たに位置づける根拠となります。前回計画は当該分野に数値目標を置いていませんでした。**

（将来の見通し）

計画期間（令和 9〜11 年）の手帳所持者数を、総人口に対する所持率を用いて **2 つの方法で推計し、幅で示します。**A は令和 8 年の所持率を据え置く方法、B は令和 5〜8 年の所持率の傾向をそのまま延ばす方法です。総人口は設定シートの町の推計（令和 11 年 7,830 人）によります。

【表 11】第１部第２章　障がいのある人を取り巻く状況（2）

手帳の種類	令和 8 年（実績）	令和 9 年	令和 10 年	令和 11 年	町の見込（令和 11 年）
身体障害者手帳	363 人	348〜353 人	334〜344 人	319〜334 人	333 人
療育手帳	72 人	69〜70 人	67〜68 人	64〜66 人	66 人
精神障害者保健福祉手帳	60 人	58〜66 人	57〜71 人	55〜75 人	56 人

資料：町の見込量・目標値設定シート（令和 8 年 9 月）の手帳所持者数と総人口から推計。幅は A（所持率の据置）と B（所持率の傾向）の小さい方〜大きい方。年齢別の所持者数を受領していないため、年齢構成の変化は入れていません（【町データ待ち】）。

身体障害者手帳と療育手帳は、どちらの方法でも減る見通しです（令和 11 年 身体 319〜334 人、療育 64〜66 人）。

精神障害者保健福祉手帳は、方法によって向きが分かれます。所持率を据え置くと 55 人に減り、傾向を延ばすと 75 人に増えます。設定シートの町の見込（56 人）は、据え置きに近い置き方です。**令和 5 年の 45 人から令和 8 年の 60 人へ、3 年で 33％増えているため、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムと相談支援の見込量は、傾向を延ばした値（B）を上限として確保の方策を考えます。**見込量に用いる値は小野町自立支援協議会にお諮りします（【協議会で設定】）。

※ 高齢者保健福祉計画・第 10 期介護保険事業計画は第 10 期将来推計用推計人口を用いており、令和 11 年の総人口は 8,232 人で、設定シート（7,830 人）と 402 人異なります（第 1 部第 2 章 1）。高齢者計画の人口の伸びを用いると、A の令和 11 年は身体 341 人・療育 68 人・精神 56 人です。**どちらの人口にそろえるかは、町と決めます（【決定後に記載】）。**

3　自立支援医療・難病・特別児童扶養手当等の状況

自立支援医療（更生医療・育成医療・精神通院医療）、指定難病の医療費助成、特別児童扶養手当等の受給者数は【町データ待ち】です。

4　障害支援区分の状況

障害支援区分の認定者数（区分別）は【町データ待ち】です。

5　障害福祉サービスの利用状況

サービス種類別の支給決定量・実利用量、町内外の事業所別の利用状況、セルフプラン件数は【町データ待ち】です。

支給決定量と実利用量を分けて把握します。両者の差は、サービスが使えなかった量を表します。見込量（第３部第２章）を実績の推移だけで置かないために必要です。

※ 第２号被保険者（40～64 歳）の介護保険の認定者のうち、障がい福祉サービスの受給者証をお持ちの方の人数は、高齢者計画と共通の把握事項です（第１部第１章 4-2 の３番）。

6　障がい児支援の利用状況

児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、障がい児相談支援の利用状況、医療的ケア児等の人数と状況、特別支援学校・特別支援学級の在籍者数と卒業予定者数は【町データ待ち】です。

※ 医療的ケア児等については、18 歳以上の医療的ケア児等・重症心身障害者を含めて把握します。医療的ケア児支援法の改正により、**支援の対象に成人期が加わりました**（令和９年４月１日施行）。個別避難計画の作成状況もあわせて把握します。

7　サービス提供体制の状況

町内・圏域の事業所の状況、町外利用と送迎の状況は【町データ待ち】です。

本町には整備されていないサービスが多く、広域連携により確保しています。就労移行支援・就労継続支援Ａ型・就労定着支援の事業所は町内になく、療育機関もありません。**町外への通所と送迎の負担が、本計画の重要な課題です**（第２部第３章２・第３部第３章３）。

8　アンケート調査の結果

今期（令和８年度）のアンケート調査の結果は【町データ待ち】です。単純集計・クロス集計・自由回答の概要を掲載します。

※ 本節は、委託仕様書の成果品「アンケート調査結果及びヒアリング調査結果報告書」の要約です。

9　関係者団体等ヒアリングの結果

相談支援事業所、サービス事業所、教育、医療、防災等の関係者からのご意見は【町データ待ち】です。

第３章　現行計画の評価と課題

1　成果目標の達成状況

現行計画（第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画）の成果目標と実績の対比は【町データ待ち】です。

※ 現行計画の目標値には、成り立たない区分があります。扱いを定めたうえで評価します（『小野町_障がい計画_前回からの追加と計画素案の構成』第３章）。

2　活動指標・サービス見込量の実績

現行計画（第７期）の実績は令和８年度末まで確定しません。ここでは、**前回計画が載せている第６期（令和３〜５年度）の見込量と実績**を整理します。**見込量の置き方の癖を読み取るためです。**

【表 12】第１部第３章　現行計画の評価と課題

サービス	単位	令和３年度	令和４年度	令和５年度	第７期の見込量
児童発達支援	人	6→7（117％）	6→4（67％）	6→6（100％）	38
児童発達支援	人日	50→28（56％）	50→20（40％）	50→24（48％）	4
共同生活援助	人	12→12（100％）	12→13（108％）	12→14（117％）	14
就労定着支援	人	1→0（0％）	1→1（100％）	1→0（0％）	0
就労移行支援	人	1→1（100％）	1→2（200％）	1→3（300％）	3
就労移行支援	人日	22→11（50％）	22→28（127％）	22→54（245％）	61
就労継続支援（Ａ型）	人	0→0（—）	0→2（—）	0→4（—）	2
就労継続支援（Ａ型）	人日	0→0（—）	0→42（—）	0→84（—）	46
就労継続支援（Ｂ型）	人	43→33（77％）	44→33（75％）	45→36（80％）	38
就労継続支援（Ｂ型）	人日	998→561（56％）	1078→595（55％）	1164→612（53％）	874
居宅介護	人	9→5（56％）	9→6（67％）	10→4（40％）	5
居宅介護	時間	25→50（200％）	25→42（168％）	26→28（108％）	30
放課後等デイサービス	人	27→32（119％）	28→33（118％）	29→31（107％）	391
放課後等デイサービス	人日	306→112（37％）	318→106（33％）	330→93（28％）	23
施設入所支援	人	19→16（84％）	19→15（79％）	19→14（74％）	15
日中一時支援事業	人	28→23（82％）	28→22（79％）	28→24（86％）	24
生活介護	人	33→31（94％）	33→29（88％）	33→28（85％）	26
生活介護	人日	728→589（81％）	728→551（76％）	728→504（69％）	728
療養介護	人	3→3（100％）	3→3（100％）	3→3（100％）	3
短期入所（福祉型）	人	2→3（150％）	2→2（100％）	2→3（150％）	0
短期入所（福祉型）	人日	17→21（124％）	17→14（82％）	17→18（106％）	0
自立訓練（生活訓練）	人	1→0（0％）	1→1（100％）	1→1（100％）	1
自立訓練（生活訓練）	人日	22→0（0％）	22→15（68％）	22→23（105％）	23
計画相談支援	人	7→11（157％）	7→12（171％）	7→12（171％）	9

資料：おのまち障がい者基本計画・第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画（令和６年３月）。**本表は同計画の PDF を機械で読み取ったもの**で、書き写していません（`ono_shogai_zenkai.py`）。「見込量→実績」の形で示し、括弧内は見込量に対する実績の割合です。令和５年度は実績見込。**実績・見込量とも全年度０のサービスは省いています**（29件）。

読み取れることが３つあります。

① 人数はおおむね見込みどおりでも、量（人日）が大きく下回ります。放課後等デイサービスは人数が見込みの 107〜119％である一方、**人日は 28〜37％**にとどまります。就労継続支援（Ｂ型）も人数 75〜80％に対し人日 53〜56％、生活介護も人数 85〜94％に対し人日 69〜81％です。**お一人あたりの利用日数が、見込みよりずっと少ない**ということです。**第８期の見込量は、人数と１人あたり日数を分けて置きます**（第３部第２章）。

② 居宅介護はこれと逆です。人数は見込みの 40〜67％ですが、時間は 108〜200％です。**少ない人数の方が、見込みより多く使っておられます。**

③ 計画相談支援は見込みを大きく上回っています（157〜171％）。**望まないセルフプランの解消（成果目標⑤）を考えるうえで、出発点となる数字です。**

前回計画の短期入所の見込量については、引き継ぐ前に確かめるべき点があります。

【表 13】第１部第３章　現行計画の評価と課題（2）

区分	第６期の実績（令和 3〜5 年度）	第７期の見込量
短期入所（福祉型）	**2〜3 人／14〜21 人日**（実績あり）	**0 人／0 人日**
短期入所（医療型）	**0 人／0 人日**（全年度 0）	**2 人／24 人日**

障がい児の第７期の見込量についても、同じく確かめる点があります。

【表 14】第１部第３章　現行計画の評価と課題（3）

サービス	第６期の実績（令和５年度）	第７期の見込量（前回計画）	見方
児童発達支援	6 人／24 人日	38 人／4 人日	「38 人・4 人日」。第６期の実績は 6 人・24〜28 人日。**人と人日が入れ替わっているとみられる**
放課後等デイサービス	31 人／93 人日	391 人／23 人日	「391 人・23 人日」。第６期の実績は 31 人・93 人日。**本町の手帳所持者は 508 人であり、月 391 人の利用はありえない**

※ 人と人日が入れ替わっているとみられます。本町の手帳所持者は 495 人（令和８年）であり、放課後等デイサービスを月 391 人が利用することはありえません。当方の読み違いである可能性も残るため、**値は前回計画のまま載せ、町に確かめたうえで第８期に用います**（【町データ待ち】）。なお、障がい児の表だけ見出しが「◆第７期の目標」となっており、ほかの「◆第７期の見込量」と違います。

※ 実績のある福祉型を 0 とし、実績のない医療型に見込みを立てています。前回計画の本文は「短期入所（医療型）については、今後も利用が見込まれることから、第７期は各年度３人、24 人日（一人あたり 12 人日）として算出しています」としていますが、**表は２人**です。24 人日÷12 人日＝2 人ですので、**本文の３人のほうが表とも計算とも合いません。第８期は、実績のある福祉型に見込みを置きます**（【町データ待ち】）。

3　分野別施策の取組状況

前回計画の第２部（障がい者計画）は、９つの分野に 49 項目の施策を掲げ、96 の取組を書いています。本計画の第２部がこれをどう引き継ぐかは、次のとおりです。

【表 15】第１部第３章　現行計画の評価と課題（4）

前回計画の章	項目	取組	本計画の章	引き継ぎ方

第２章　差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止	3	6	**第２章**　差別解消・権利擁護の推進	**意思決定支援を独立した節（3）として加えます**（基本指針 別表第二 六の項④）
第３章　安全・安心な生活環境の整備	6	11	**第３章**　安全・安心な生活環境の整備	**住宅セーフティネット法の居住支援協議会を加えます。**節の構成は前回どおり
第４章　情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実	3	4	**第４章**　情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実	**前回は節がありませんでした。**町条例（令和７年４月）を根拠に**３つの節を立てます**
第５章　防犯・防災の推進	3	11	**第５章**　防犯・防災の推進	**個別避難計画を厚く書きます。**医療的ケア児等支援センターの協力（令和９年４月施行）を加えます
第６章　保健・医療の推進	9	18	**第６章**　保健・医療の充実	**医療的ケア児等への支援を新たな節（3）として加えます。**にも包括を第１節に位置づけます
第７章　自立した生活の支援・意思決定支援の推進	9	18	**第７章**　自立生活支援・相談支援体制の充実	**３節を６節に広げます**（地域生活支援拠点／家族介助者／経済的負担／65 歳到達）。**意思決定支援は第２章３へ、障がい児支援は第６章３・第８章へ**
第８章　教育の振興	6	9	**第８章**　教育の振興	**18 歳移行を見据えた進路支援を新たな節（4）として加えます**
第９章　雇用・就業、経済的自立の支援	8	14	**第９章**　雇用・就業、経済的自立の支援	**就労選択支援（令和７年 10 月創設）を第１節に加えます**
第 10 章　文化芸術活動・スポーツ活動等の進行	2	5	**第 10 章**　文化芸術活動・スポーツ等の振興	**３つの節を立てます。**前回の節の名は第９章のものが入っていました（下記）

資料：おのまち障がい者基本計画・第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画（令和６年３月）第２部。**項目は「施策の方向」の①②③…、取組はその下の〇の数**を原本から数えたものです（`ono_shogai_zenkai.py`）。**各取組が実際にどこまで行われたかは【町データ待ち】です。**

分野によって厚みが違います。保健・医療（９項目 18 取組）と自立した生活の支援（９項目 18 取組）が最も厚く、**情報アクセシビリティ（３項目４取組）と文化芸術活動・スポーツ（２項目５取組）が最も薄い**構成でした。**本計画では、情報アクセシビリティに３つの節を立てて厚くします。**令和７年４月に町条例が施行されたためです（第２部第４章）。

９つの分野はすべて引き継ぎます。そのうえで、本計画では次の３つを組み替えます。

① 意思決定支援を、前回の第７章（自立した生活の支援）から第２章（差別解消・権利擁護）の独立した節に移します。基本指針が権利擁護の文脈で求めているものだからです。

② 前回の第７章３（障がいのある子どもに対する支援の充実）を、第６章３（医療的ケア児等への支援）と第８章（教育の振興）に分けます。医療的ケア児支援法の改正により、支援の対象に 18 歳以上の医療的ケア児等・重症心身障害者が加わったためです。

③ 前回の第４章（情報アクセシビリティ）には節がありませんでした。令和７年４月の町条例の施行を受けて、３つの節を立てます。

前回計画には、本計画で繰り返してはならない誤記が２件あります。

【表 16】第１部第３章　現行計画の評価と課題（5）

箇所	前回計画の記載	正しくは

第 10 章のページヘッダ	文化芸術活動・スポーツ活動等の**進行**	目次と本文の見出しは「**振興**」。ヘッダだけが誤り
第 10 章の節の名	1 **総合的な就労支援**	**第９章第１節の名がそのまま入っている。**章は文化芸術活動・スポーツ活動等の振興

※ いずれも第 10 章です。節の名は第９章第１節の名がそのまま入っており、**章の中身（文化芸術活動・スポーツ活動）と合っていません。**本計画の第 10 章は、３つの節（文化芸術活動の振興／スポーツ・レクリエーションの振興／地域交流・社会参加の促進）を立てます。

4　次期計画に向けた課題

前回調査及びヒアリングから、次期計画に向けた課題を次のとおり整理しました。**今期調査の結果を受けて確定します。**

【表 17】第１部第３章　現行計画の評価と課題（6）

調査項目	前回調査の結果	本計画での箇所
地域で生活するために必要な支援（最多）	経済的な負担の軽減　54.6％	第２部第７章５
外出の目的（最多）	医療機関への受診　73.0％	第２部第６章２
在宅で医療的なケアを受けている	43.2％	第２部第６章３
相談相手	家族　79.6％／医療職　32.9％	第２部第７章１
災害時に一人で避難できない	障がいのある方　35.4％／障がいのある子ども　54.5％	第２部第５章１
個別避難計画の作成を希望する	30.7％／40.9％（同上の別）	第２部第５章１
投薬・治療が受けられない不安	50.7％	第２部第５章１・第６章２
主介助者が 70 歳以上	35.6％	第２部第７章４
主介助者の健康状態が「よくない」	19.8％	第２部第７章４
障がい児の主介助者が女性	94.1％	第２部第７章４
成年後見制度を「名前も内容も知らない」	約４割	第２部第２章１
差別や嫌な思いの経験	障がいのある方　約３割／障がいのある子ども　約７割／精神障がいのある方　約６割	第２部第２章２
外出時の困りごと（精神障がいのある方の費用）	44.1％	第２部第３章２
障がい児の今後の利用意向	就労系　63.6％／放課後等デイサービス　63.6％	第２部第８章４・第９章１
障がい児の進路希望（最多）	特別支援学校高等部　45.0％	第２部第８章４

資料：おのまち障がい者基本計画・第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画（令和６年３月）策定時の調査。**今期調査の結果は【町データ待ち】であり、受領後に本表を今期の値に置き換えます。**

第２部　おのまち障がい者計画

本部は、障害者基本法第 11 条第３項に基づく市町村障害者計画です。現行計画の分野を継承し、10 の章により施策の方向を示します。各章は「現状と課題」と「施策の方向」で構成します。

【表 18】第２部　おのまち障がい者計画

章	分野	節数
第１章	基本的な考え方	4 節
第２章	差別解消・権利擁護の推進	3 節
第３章	安全・安心な生活環境の整備	3 節
第４章	情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実	3 節
第５章	防犯・防災の推進	3 節
第６章	保健・医療の充実	5 節
第７章	自立生活支援・相談支援体制の充実	6 節
第８章	教育の振興	4 節
第９章	雇用・就業、経済的自立の支援	4 節
第 10 章	文化芸術活動・スポーツ等の振興	3 節

第１章　基本的な考え方

1　基本理念

基本理念は、現行計画の理念を基本としつつ、小野町自立支援協議会にお諮りして定めます（【協議会で設定】）。

2　基本目標

基本目標は【協議会で設定】です。

3　施策体系

施策体系は、本部の第２章から第10章までの９分野と、第３部の成果目標・見込量を対応させた形で示します（【協議会で設定】）。

4　横断的視点

次の視点を、すべての分野に通じるものとして置きます。

- **障がいのある方の意思の尊重と意思決定支援**
- **障がいの特性に応じた配慮**（身体・知的・精神・発達・難病・高次脳機能障がい）
- **ライフステージを通じた切れ目のない支援**（早期療育・就学・18歳移行・65歳到達）
- **家族への支援**（法第77条第１項第３号の改正により法定の視点となりました）
- **地域共生社会の実現**（第３期地域福祉計画との連携）

第２章　差別解消・権利擁護の推進

現状と課題

前回調査では、差別や嫌な思いを経験した方が障がいのある方で約３割、障がいのある子どもで約７割、精神障がいのある方で約６割に上ります。**障害者差別解消法の認知は、とりわけ障がいのある子どもで低い**状況です。成年後見制度を「名前も内容も知らない」方は約４割です。

施策の方向

1　権利擁護の推進、虐待の防止

・障がいのある方への虐待の防止と早期発見に努めます。**虐待防止センターの連絡先を、サービス利用の有無にかかわらず周知します。**

・**成年後見制度の周知と利用支援**を進めます。制度を「名前も内容も知らない」方が約４割である現状を踏まえ、広報と、支援者を通じた個別の働きかけの両方で行います。中核機関の体制は第３期地域福祉計画と整合を図ります（【町データ待ち】）。

2　差別の解消の推進

・障害者差別解消法と**合理的配慮**の周知を、広報おのまちと防災無線を軸に行います。**抽象的な説明ではなく、町内で実際にあった配慮の例を示します。**

・**障がいのある子どもへの周知を特に手厚くします。**差別や嫌な思いの経験が約７割と最も高い一方、法の認知が最も低い層です。学校を通じた周知を行います。

3　意思決定支援の推進

・**障がいのある方ご本人の意思を尊重した支援**を進めます（基本指針 別表第二 六の項④）。相談支援専門員・サービス管理責任者を通じて意思決定支援の考え方を共有します。

・**本人の意思を確かめる手だてを、計画相談支援の過程に組み込みます。**セルフプランの方についても、意思の確認の機会を確保します（第７章１）。

【表 19】第２部第２章　差別解消・権利擁護の推進

成果指標（案）	現状値	目標値
第２章の指標	【町データ待ち】	【協議会で設定】

第３章　安全・安心な生活環境の整備

現状と課題

外出時の困りごととして、段差、公共交通の少なさ、費用が挙げられています（費用は精神障がいのある方で44.1％）。**町内に療育機関がなく、町外への通所と送迎の負担が生じています。**住まいについては、グループホームの定員、公営住宅の入居、住宅セーフティネット制度の利用の状況が【町データ待ち】です。

施策の方向

1　住宅の確保

・**住宅確保要配慮者の居住支援**について、住宅セーフティネット法に基づく県の計画（福島県賃貸住宅供給促進計画）と整合を図ります。

・**居住支援協議会**（住宅セーフティネット法第81条第１項）の設置状況を確かめ、連携先として位置づけます（【町データ待ち】）。

・**グループホームからの地域移行、単身生活への移行**の受け皿として、公営住宅と民間賃貸住宅の双方を視野に入れます（成果目標①と対応します）。

2　移動しやすい環境の整備

・移動支援事業・日中一時支援事業の利用により、外出の機会を確保します。**外出の目的の最多は医療機関への受診（73.0％）であり、通院の支援と切り離せません**（第６章２）。

・**町外の事業所に通う方の送迎**について、実態を把握したうえで支援の在り方を検討します（第３部第３章３）。

・小野町地域公共交通計画と整合を図り、町営バス・デマンド型交通の利用しやすさを高めます。**費用の負担が外出の障壁となっている**（精神障がいのある方で44.1％）ことを踏まえます。

3　まちづくりの総合的な推進

・**まちづくりの総合的な推進**は、小野町総合計画に基づく公共施設の整備にあわせて進めます。段差の解消など、個別の改修の機会を捉えて行います。

【表20】第２部第３章　安全・安心な生活環境の整備

成果指標（案）	現状値	目標値
第３章の指標	【町データ待ち】	【協議会で設定】

第４章　情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実

現状と課題

令和７年４月に小野町手話言語及び障がい者コミュニケーション条例が制定されました。 また、国においても**手話に関する施策の推進に関する法律（令和７年６月）**が成立しています（**法律番号は原典で確かめたうえで記載します**）。**前回計画には意思疎通支援を独立させた節がありませんでした。**

施策の方向

１　手話言語条例に基づく取組

・**町条例に基づき、手話を言語として普及させる取組を進めます。**手話奉仕員養成研修の実施、職員・住民向けの学習の機会を確保します。

・**条例に基づく取組と、地域生活支援事業の見込量（第３部第２章６）を同じ考え方で定めます。**条例を掲げるだけで量を置かない、ということのないようにします。

２　多様な意思疎通支援

・手話のほか、**要約筆記、点字、音声、わかりやすい表現、意思疎通支援用具**など多様な手段による意思疎通を支援します。

・**意思疎通支援事業・手話奉仕員養成研修事業**は、地域生活支援事業の必須事業です。利用の実績と必要量を把握したうえで見込量を置きます。

３　情報提供の工夫

・**町の情報提供そのものを工夫します。**広報おのまち・防災無線・町公式ウェブサイトのそれぞれについて、障がいの特性に応じた届け方を定めます。

・**災害時の情報提供**は、平時の仕組みの延長にあります（第５章１）。

【表 21】第２部第４章　情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実

成果指標（案）	現状値	目標値
第４章の指標	【町データ待ち】	【協議会で設定】

第５章　防犯・防災の推進

現状と課題

災害時に一人で避難できない方は、障がいのある方で35.4％、障がいのある子どもで54.5％です。個別避難計画の作成を希望する方は30.7％・40.9％、投薬・治療が受けられない不安を挙げた方は50.7％でした。**成人と児童で課題の性質が異なります。**

施策の方向

１　防災対策の推進

・**避難行動要支援者名簿への登載と、個別避難計画の作成を進めます。**名簿の登載者数と個別避難計画の作成状況は【町データ待ち】です。

・**服薬・医療機器・電源の確保**を個別避難計画に具体的に書き込みます。在宅で人工呼吸器等を使用する方の電源の確保は、平時からの備えがなければ間に合いません。

・**医療的ケア児等については、医療的ケア児等支援センターの業務に個別避難計画の作成への協力が加わります**（令和９年４月１日施行）。県のセンターとの連携を図ります。

・福祉避難所の確保と、避難所での情報取得・意思疎通支援に努めます（第４章３）。

２　防犯対策の推進

・**防犯について、地域の見守りと、警察・消防との連携**を進めます。**成人と児童で必要な配慮が異なります。**障がいのある子どもの登下校時の見守りは、学校・保護者・地域が連携して行います。

３　消費者トラブルの防止

・**消費者トラブルの防止**について、相談窓口の周知と、支援者を通じた見守りを行います。**意思決定支援（第２章３）と成年後見制度（第２章１）につながる事柄です。**

【表22】第２部第５章　防犯・防災の推進

成果指標（案）	現状値	目標値
第５章の指標	【町データ待ち】	【協議会で設定】

第６章　保健・医療の充実

現状と課題

精神障害者保健福祉手帳の所持者が45人（令和５年）から60人（令和８年）に増えています。前回計画では、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムに数値目標を置いていませんでした。外出の目的の最多は医療機関への受診（73.0％）で、在宅で医療的なケアを受けている方が43.2％です。

施策の方向

１　精神保健・医療と精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム

・**精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築**について、**県中医療圏の協議の場に参加します。成果目標は県が設定し、町は活動指標を置く構えです**（第３部第１章②）。

・福島県保健医療計画 第８章第５節と整合を図ります。県中医療圏における精神科医療の体制は県に照会中です（【決定後に記載】）。

・**心のサポーター**の養成など、住民の理解を広げる取組を進めます。

２　医療・リハビリテーションの充実

・**通院の支援**を進めます。外出目的の最多が受診であることから、移動支援（第３章２）と一体で取り組みます。

・医療・リハビリテーションの充実について、**公立小野町地方綜合病院**をはじめとする町内の医療機関、県中医療圏の医療機関との連携を図ります。

・**高次脳機能障がいのある方への支援**について、県の支援拠点機関との連携により相談に応じます。

３　医療的ケア児等への支援

・**医療的ケア児等への支援に取り組みます。医療的ケア児支援法の改正（令和８年法律第77号・令和９年４月１日施行）により、支援の対象に18歳以上の医療的ケア児等と重症心身障害者が加わりました。本町も、成人期を含めて支援します。**

・**就労支援（同法第11条の３）・住居の確保（同法第11条の４）**についても、関係機関と連携して取り組みます（第３部第１章⑧）。

・**医療的ケア児等コーディネーターの配置**を進めます。県の医療的ケア児等支援センターが市町村への配置促進に努めることとされています（福島県保健医療計画 第８章第11節）。

・本町の医療的ケア児等の人数と状況は【町データ待ち】です。

４　難病に関する施策

・難病に関する施策について、**県中保健所・難病相談支援センター**との連携を図ります。本町の難病患者の把握状況は【町データ待ち】です。

・**難病のある方は手帳をお持ちでない場合があります。**手帳の有無で支援の対象を切らないようにします（第１部第１章６）。

５　健診・早期発見と疾病等の予防

・健診・早期発見と疾病等の予防を、小野町の保健事業と一体で進めます。

・**乳幼児健診から療育へのつなぎ**を切れ目のないものにします（第８章１）。

【表23】第２部第６章　保健・医療の充実

成果指標（案）	現状値	目標値
第６章の指標	【町データ待ち】	【協議会で設定】

第７章　自立生活支援・相談支援体制の充実

現状と課題

前回調査で「地域で生活するために必要な支援」の最多は**経済的な負担の軽減（54.6％）**でした。相談相手は家族 79.6％・医療職 32.9％に偏っています。主介助者の 70 歳以上が 35.6％、健康状態が「よくない」方が 19.8％、障がいのある子どもでは主介助者の 94.1％が女性です。**相談支援専門員の確保が課題で、望まないセルフプランの発生が懸念されます。**

施策の方向

1　相談支援体制の充実

・**相談支援体制**について、基幹相談支援センター・支援協議会・事業所連絡会の役割分担を明らかにします。

・**望まないセルフプランの解消**を第３部第１章⑤の成果目標と対応させます。セルフプラン件数と相談支援専門員数は【町データ待ち】です。

・**相談相手が家族（79.6％）に偏っている**ことを踏まえ、家族以外の相談先を知っていただく取組を行います。

2　地域生活支援拠点等の機能の充実

・**地域生活支援拠点等**について、相談・緊急時の受入れ・体験の機会・専門的人材・地域の体制づくりの**５つの機能ごとに運用状況を点検**します（第３部第１章③）。

・**地域包括支援センターとの窓口の重なり**を整理します（第１部第１章 4-2 の５番）。

3　障がい福祉サービスの充実

・障がい福祉サービスの充実を図ります。**町内に整備されていないサービスが多く、広域連携で確保しています**（第３部第３章２）。

・**共生型サービス**の指定を受けた事業所の有無を確かめ、両制度にまたがる利用に備えます（第１部第１章 4-2 の２番）。

4　家族介助者への支援・親亡き後

・**家族介助者への支援**に力を入れます。短期入所・日中一時支援による**レスパイト**を確保します。

・**親亡き後**を見据えた住まいと支援の確保を進めます。主介助者の 70 歳以上が 35.6％である現状は、この課題が先の話ではないことを示しています。

・**障害者総合支援法第 77 条第１項第３号の改正により、相談支援事業に「家族その他の関係者の状況を考慮しつつ」が加わりました**（令和９年４月１日施行）。**家族支援の視点が法定のものとなりました。**

5　経済的負担の軽減

・**経済的負担の軽減**について、利用者負担の軽減制度、手当・年金、税の減免、各種割引の周知を行います。

・**調査で最多に挙げられた事項です。**制度があっても知られていなければ使われません。**周知の方法まで含めて取り組みます。**

6　65 歳到達時の介護保険への移行

・**65 歳到達時の介護保険への移行**について、**高齢者保健福祉計画と同じ考え方で取り扱います**（第１部第１章 4-2 の１番）。両計画を同時に策定していることを活かします。

・介護保険優先原則の下でも、**障がい福祉サービスの継続利用が認められる場合があります。**一律に切り替えることのないよう、個別に判断します。

・令和 9〜11 年度に 65 歳に達する方の一覧は【町データ待ち】です。

【表 24】第２部第７章　自立生活支援・相談支援体制の充実

成果指標（案）	現状値	目標値
第７章の指標	【町データ待ち】	【協議会で設定】

第８章　教育の振興

現状と課題

障がいのある子どもの進路希望は特別支援学校高等部が 45.0％で最多です。今後の利用意向は就労系 63.6％・放課後等デイサービス 63.6％でした。**町内に療育機関がなく、町外への通所となっています。**

施策の方向

1　早期発見・早期療育

・早期発見・早期療育について、**乳幼児健診から療育へのつなぎ**を切れ目のないものにします（第６章５）。

・**町内に療育機関がないため、町外への通所となります。**送迎の負担を踏まえた支援を検討します（第３部第３章３）。

2　インクルーシブ教育システムの推進

・**インクルーシブ教育システムの推進**について、就学相談・巡回相談・特別支援学校との連携を進めます。

・**保育所等訪問支援**の利用を進め、通常の学級・保育の場での支援を厚くします。

3　教育環境の整備

・教育環境の整備について、学校における**合理的配慮**の提供と支援員の配置を進めます。

・**障がいのある子どもの差別の経験が約７割**と最も高いことを踏まえ、学校における理解の促進を図ります（第２章２）。

4　18 歳移行を見据えた進路支援

・**18 歳移行を見据えた進路支援**に取り組みます。**放課後等デイサービスの卒業と日中活動系サービスへの接続**を、第３部第２章の見込量に反映させます。

・**就労選択支援**（令和７年 10 月創設）の利用の機会を確保します（第９章１・第３部第１章④）。

・高等部への通学支援について検討します。

【表 25】第２部第８章　教育の振興

成果指標（案）	現状値	目標値
第８章の指標	【町データ待ち】	【協議会で設定】

第９章　雇用・就業、経済的自立の支援

現状と課題

就労移行支援・就労継続支援Ａ型・就労定着支援の事業所が町内になく、町外の事業所との連携で対応しています。令和７年10月に就労選択支援が創設されました。

施策の方向

１　総合的な就労支援（就労選択支援を含む）

・**就労選択支援の利用の機会を確保します。**国は圏域単位での設置を目標としており、**町としては利用の機会の確保を指標とします**（第３部第１章④）。

・特別支援学校卒業予定者の進路希望から新規の需要を積み上げ、見込量に反映させます（第３部第２章２）。

・**令和９年４月からは、新たに就労継続支援Ａ型を利用する方と、就労移行支援の標準利用期間を超えて利用する方も、就労選択支援により課題が把握されていることが利用の前提となる予定です**（第160回社会保障審議会障害者部会 資料１、令和８年10月20日）。就労選択支援の見込量には、Ａ型の新規利用の見込みを加えます（第３部第２章。Ａ型の新規利用の見込みは【町データ待ち】）。

２　障がい者雇用の促進

・障がい者雇用の促進について、**ハローワーク・障害者就業・生活支援センター**との連携を図ります。

・**職場の理解**を広げる取組と、**通勤の支援**について検討します。

３　福祉的就労の充実

・就労継続支援Ｂ型を中心とする福祉的就労の充実と、**農福連携**等による就労機会の確保を図ります。

・**町内に就労系の事業所がない**ため、町外の事業所との連携が前提となります（第３部第３章２・３）。

４　経済的自立の支援

・経済的自立の支援について、工賃の向上を図ります。

・**経済的負担の軽減（第７章５）と合わせて、収入と支出の両面から考えます。**

【表26】第２部第９章　雇用・就業、経済的自立の支援

成果指標（案）	現状値	目標値
第９章の指標	【町データ待ち】	【協議会で設定】

第 10 章　文化芸術活動・スポーツ等の振興

現状と課題

文化芸術活動・スポーツへの参加は、社会参加と地域交流の機会です。本町における参加の状況は【町データ待ち】です。

施策の方向

1　文化芸術活動の振興

・文化芸術活動の振興について、発表と鑑賞の機会の確保に努めます。

2　スポーツ・レクリエーションの振興

・スポーツ・レクリエーションの振興について、参加しやすい機会づくりを進めます。

3　地域交流・社会参加の促進

・地域交流・社会参加の促進について、**地域活動支援センターの活用**と、住民との交流の機会づくりを進めます。

・**地域共生社会の実現**に向けて、第３期地域福祉計画の地域づくりと一体で進めます。

【表 27】第２部第 10 章　文化芸術活動・スポーツ等の振興

成果指標（案）	現状値	目標値
第 10 章の指標	【町データ待ち】	【協議会で設定】

第３部　第８期障がい福祉計画・第４期障がい児福祉計画

本部は、障害者総合支援法第 88 条第１項に基づく市町村障害福祉計画及び児童福祉法第 33 条の 20 第１項に基づく市町村障害児福祉計画です。国の基本指針（令和８年３月 31 日告示）に即して、成果目標・活動指標・サービス見込量を定めます。

※ 第８期の基本指針は、医療的ケア児支援法の改正（令和８年法律第 77 号）を踏まえて再改正される見込みです。再改正の範囲と時期を県に照会しています（【決定後に記載】）。

第１章　成果目標

国の基本指針が示す８つの分野に対応して、成果目標を設定します。**目標値は【協議会で設定】です。**

【表 28】第３部第１章　成果目標

分野	目標項目	第７期の設定	第８期の設定方針
①　施設入所者の地域生活移行	地域生活移行者数、施設入所者数の削減	**令和４年度末 26 人に対し、移行 31 人（119.2％）・削減 22 人（84.6％）**	令和７年度末の確定値を基準に、国の考え方に基づき設定（【協議会で設定】）。基準となる令和７年度末の施設入所者数は【町データ待ち】。**前回計画の目標値は成り立たない（下記）**
②　精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築	退院後１年以内の地域における平均生活日数、再入院率、心のサポーター	**設定なし**	**成果目標は県が設定し、町は活動指標を置く。**県中医療圏の協議の場への参加状況を指標とする（県に照会中。【協議会で設定】）
③　地域生活支援の充実	地域生活支援拠点等の整備・機能の充実、強度行動障がい者の支援体制	拠点１か所・コーディネーター１人の維持、強度行動障がい（無→有）	**拠点の５つの機能ごとに運用状況を評価して設定**（【協議会で設定】）
④　福祉施設から一般就労への移行等	一般就労移行者数、就労定着支援利用者数、就労選択支援	移行者数・定着支援利用者数を設定	**就労選択支援は利用の機会の確保を指標とする**（【協議会で設定】）
⑤　相談支援体制の充実・強化等	基幹相談支援センターの設置・機能、望まないセルフプランの解消	設置維持、指導・助言件数	**望まないセルフプランを令和 11 年度末までにゼロとする**国の新規目標に対応。現状件数は【町データ待ち】
⑥　障害福祉サービス等の質の向上	研修参加、情報公表制度の公表率・更新率	県研修への参加等	**情報公表制度の公表率・更新率 100％**（国の新規目標）
⑦　障害福祉人材の確保・定着、生産性向上	人材確保、生産性向上の取組	（**新規の柱**）	**国は都道府県にワンストップ窓口・連携協議会を求める。**町の取組は**県と連携した取組**として置く（法第 88 条第３項第３号～第５号）
⑧　障害児支援の提供体制の整備等	児童発達支援センター、保育所等訪問支援、重症心身障がい児対応事業所、医療的ケア児等コーディネーター、インクルージョン推進のための協議の場	センター等各１か所の維持、重症心身障がい児対応・医療的ケア児等コーディネーターの整備	**医療的ケア児支援法の改正を踏まえ、成人期（18 歳以上の医療的ケア児等・重症心身障害者）を含む構えで設定。**インクルージョン推進の協議の場の設置（国の新規目標）を追加

② は、成果目標そのものを県が設定し、町は活動指標を置く構えです。県中医療圏の協議の場の設置状況を県に照会しています。**現行計画では当該分野に数値目標を置いていませんでした。**精神障害者保健福祉手帳の所持者が２年間で 37.8％増えていることから、**本計画で新たに位置づけます。**

⑦は国の基本指針の新たな柱です。法第88条第３項第３号から第５号まで（いずれも新設）は、いずれも「都道府県と連携した取組に関する事項」と定めています。町単独の取組ではなく、県との連携を軸に置きます（第３章４）。

⑧は、医療的ケア児支援法の改正により、支援の対象に18歳以上の医療的ケア児等と重症心身障害者が加わったことを踏まえた構えとします。就労支援（第11条の３）・住居の確保（第11条の４）も新たに置かれており、成人期を含めて設定します。

1-1　前回計画の成果目標①は成り立ちません

前回計画（第７期）は、施設入所者の地域生活移行の目標を次のように定めています。

【表29】第３部第１章　成果目標（2）

項目	前回計画の値	26人に対する割合	見方
令和４年度末の施設入所者数	**26人**	—	基準となる人数
【目標値】令和８年度末の地域生活移行者数	**31人**	**119.2％**	**入所者26人より多い人数が移行することはできません**
【目標値】令和８年度末の削減見込者数	**22人**	**84.6％**	**削減後は４人。しかし同じ計画の見込量は施設入所支援15人です**

資料：おのまち障がい者基本計画・第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画（令和６年３月）第３部第５章。**国の基本指針は「令和４年度末時点の施設入所者の６％以上が令和８年度末までに地域生活へ移行」「令和８年度末時点の施設入所者を令和４年度末時点から５％以上削減」としています。**26人に当てはめると、**移行は1.56人（２人）、削減は1.30人（２人）**です。

第８期は、令和７年度末の確定値を基準に、国の考え方に当てはめて設定します。成果目標と見込量（第２章）が互いに矛盾しないことを、設定のつど確かめます。前回計画の目標値の由来は町に確かめています（【町データ待ち】）。

第２部の分野別施策と成果目標の対応は、次のとおりです。

【表30】第３部第１章　成果目標（3）

成果目標	対応する第２部の章
① 施設入所者の地域生活移行	第７章２・３（地域生活支援拠点等）
② にも包括	**第６章１**（精神保健・医療）
③ 地域生活支援の充実	第７章２（地域生活支援拠点等）
④ 一般就労への移行等	**第９章１**（就労選択支援を含む）
⑤ 相談支援体制の充実・強化等	**第７章１**（望まないセルフプラン）
⑥ 質の向上	第７章３
⑦ 人材の確保・定着、生産性向上	**第３部第３章４**（県と連携した取組）
⑧ 障害児支援の提供体制	**第６章３・第８章１・第８章４**

第２章　活動指標・サービス見込量

サービスの種類ごとに、令和９年度から令和11年度までの見込量を設定します。**数値は【算定後に記載】です。**

算定方式は次のとおりとし、実績の推移のみで機械的に設定しません。

【表31】第３部第２章　活動指標・サービス見込量

区分	サービス	算定方式	留意点
1　訪問系	居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援	実績推移型＋アンケート補正／重度訪問介護は個別積上げ型	**実績０でも候補者の有無を確認し、０見込の根拠を記録する。**介護保険移行との二重計上を避ける
2　日中活動系	生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援Ａ型・Ｂ型、就労定着支援、就労選択支援、療養介護、短期入所	**人数×１人あたり日数**（日数は実績の値）＋18歳移行の個別積上げ／就労選択支援・療養介護は個別積上げ型	**就労選択支援は令和７年10月創設。**特別支援学校卒業予定者の進路希望から新規需要を積み上げる。**令和９年４月からＡ型の新規利用者等も対象となる予定のため、Ａ型の新規利用の見込みを加える**
3　居住系	共同生活援助、施設入所支援、自立生活援助	実績推移型＋地域移行・親亡き後の個別積上げ	**施設入所者の地域生活移行（成果目標①）と整合させる**
4　相談支援	計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障がい児相談支援	セルフプランからの移行を見込む積上げ型	**望まないセルフプランの解消（成果目標⑤）と整合させる**
5　障がい児支援	児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、医療型児童発達支援、障がい児入所支援	**人数×１人あたり日数**（日数は実績の値）＋町外療育の実態を踏まえた補正	**町内に療育機関がなく町外通所・送迎負担がある。**18歳到達に伴う放課後等デイの卒業と日中活動への接続を見込む
6　地域生活支援事業	理解促進研修・啓発、自発的活動支援、相談支援、成年後見制度利用支援、意思疎通支援、日常生活用具、手話奉仕員養成、移動支援、地域活動支援センター、日中一時支援等	実績推移型＋施策との整合	**意思疎通支援は手話言語条例に基づく取組（第２部第４章）と整合させる。**移動支援は外出の課題と接続する

※ 本町には、国の基本指針の別表第五（地域差の是正）の適用はありません。 別表第五は、一の項の要件（全部過疎市町村ではないこと、かつ、人口に占めるサービスの利用者の割合が上位25％の範囲内であること）に該当する市町村について、生活介護、就労継続支援Ａ型・Ｂ型、共同生活援助、児童発達支援及び放課後等デイサービスの見込量の算定方法を定めています。**本町は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第２条第１項の過疎地域市町村（全部過疎）であり、一の項の要件を満たしません。**（福島県「福島県過疎地域持続的発展方針・計画について」令和８年４月１日更新、総務省「過疎関係市町村都道府県別分布図」令和４年４月）

2-1　量は「人数×１人あたり日数」で置きます

第６期の見込量と実績を突き合わせると、人数はおおむね見込みどおりである一方、量（人日）が大きく下回っていました（第１部第３章２）。**原因は、１人あたりの利用日数を高く見積もっていたことにあります。**

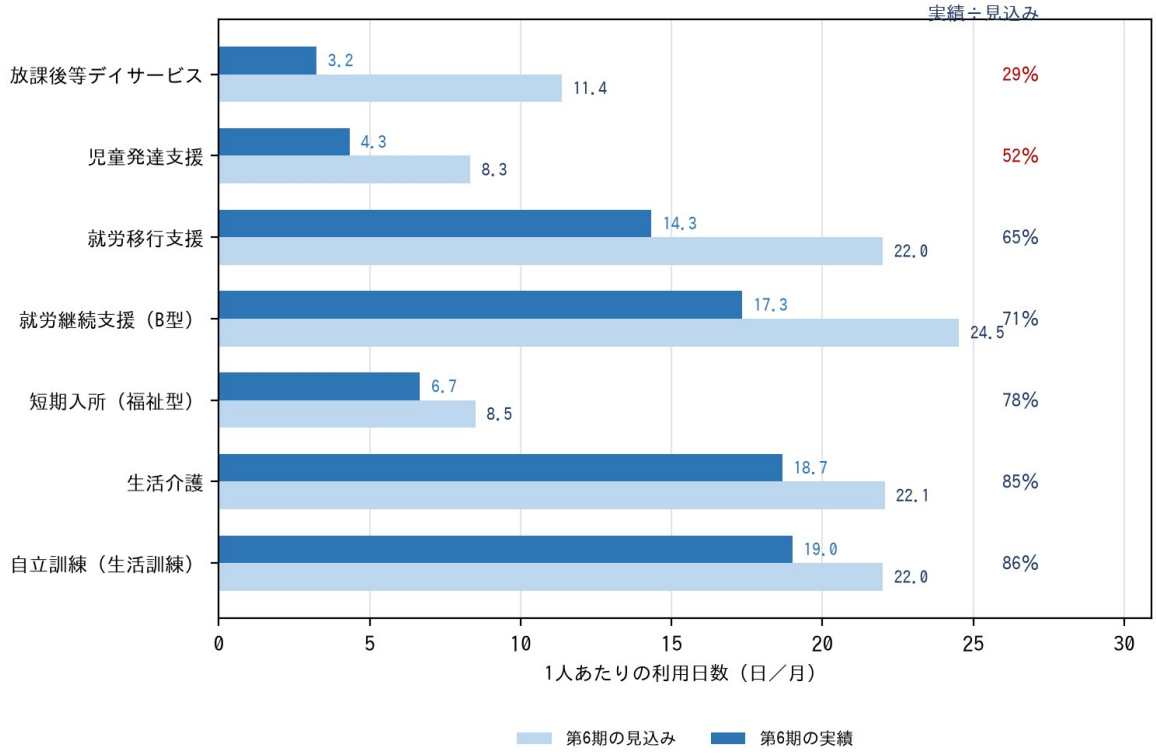
【表32】第３部第２章　活動指標・サービス見込量（２）

サービス	第６期の見込み １人あたり日数	第６期の実績 １人あたり日数	見方
児童発達支援	8.3日	4.0〜5.0日	**町内に療育機関がない**（第２部第８章１）
就労移行支援	22.0日	11.0〜18.0日	実績が年々増えている（11.0→18.0日）

就労継続支援（A 型）	—	21.0 日	**第 6 期は見込み 0。**実績のみ 21.0 日
就労継続支援（B 型）	23.2〜25.9 日	17.0〜18.0 日	見込みはほぼ全開所日。実績は月 17〜18 日
放課後等デイサービス	11.3 日	3.0〜3.5 日	**見込み週 2〜3 回に対し実績は週 1 回に満たない。**町外通所の負担（第 2 部第 3 章 2）
生活介護	22.1 日	18.0〜19.0 日	見込みはほぼ全開所日。実績は月 18〜19 日
短期入所（福祉型）	8.5 日	6.0〜7.0 日	見込み 8.5 日に対し実績 6.0〜7.0 日
自立訓練（生活訓練）	22.0 日	15.0〜23.0 日	利用が 1 人のため幅が大きい

資料：前回計画の見込量・実績から当方が算出（人日÷人。令和 3〜5 年度の幅）。**実績の人数が 0 の年度は「—」としています。**

【図 2】第 3 部第 2 章 2-1　1 人あたりの利用日数　見込みと実績



資料：前回計画（令和 6 年 3 月）の第 6 期の見込量・実績から当方が算出（令和 3〜5 年度の平均）。**右端は実績÷見込み。6 割を下回るものを赤で示す**

放課後等デイサービスがとりわけ大きく離れています。見込みは 1 人あたり月 11.3 日（週 2〜3 回）でしたが、実績は**月 3.0〜3.5 日（週 1 回に満たない）**でした。児童発達支援も見込み 8.3 日に対し実績 4.0〜5.0 日です。**町内に療育機関がなく、町外へ通うことになる**ため、通える回数が限られているものと考えられます（第 2 部第 3 章 2・第 8 章 1）。

日中活動系も同じ向きです。生活介護は見込み 22.1 日（ほぼ全開所日）に対し実績 18.0〜19.0 日、就労継続支援（B 型）は見込み 23.2〜25.9 日に対し実績 17.0〜18.0 日です。

そこで第 8 期は、見込量を次の形で置きます。

・**量（人日）＝ 見込人数 × １人あたり日数**

・**１人あたり日数は、前回計画が用いた値ではなく、直近の実績の値を出発点とします。**引き上げる場合は、**何をすれば日数が増えるのかを施策（第２部）の側に書いたうえで**行います。

・**人数と１人あたり日数を分けて示します。**どちらがずれたのかが、毎年度の点検で分かるようにするためです（第４部３）。

※ １人あたり日数を実績どおりに置くことは、利用を増やさないという意味ではありません。増やすのであれば、通えない理由（送迎・費用・事業所の有無）を施策で取り除く必要があり、その手当てと対にして日数を置きます。手当てのないまま日数だけを高く置くと、第６期と同じことが繰り返されます。

2-2　地域生活支援事業は、実績も見込量も０のものが並んでいます

前回計画の地域生活支援事業（11 事業）のうち、次の４つは第６期の実績も第７期の見込量もすべて０です。

【表 33】第３部第２章　活動指標・サービス見込量（3）

事業	第６期の実績（令和３〜5年度）	第７期の見込量	本計画での扱い
意思疎通支援事業（手話通訳者・要約筆記者派遣／手話通訳者設置／点訳・代筆・代読・音声訳等）	**０人・０か所**	**０人・０か所**	**令和７年４月に町条例が施行されました**（第２部第４章）。**条例を掲げて量を０のままにはできません**
手話奉仕員養成研修事業	**０人**	**０人**	同上。**養成しなければ派遣もできません**
移動支援事業	**０人・０時間**	**０人・０時間**	**第２部第３章２で外出支援の柱に置いています。**外出の困りごと（段差・公共交通・費用）と合いません
地域活動支援センター	**０人・０時間**	**０人・０時間**	第２部第10章３で社会参加の場に挙げています

資料：前回計画 第３部第８章。**実績のある事業は、日中一時支援事業（22〜24 人）と訪問入浴サービス事業（1〜2 人／年）です。令和 6〜8 年度の実績は【町データ待ち】です。**

０が続いていることには、２つの読み方があります。①必要がなかった。②必要はあったが、使える形になっていなかった。どちらであるかによって、本計画ですべきことが正反対になります。

本町は令和７年４月に手話言語及び障がい者コミュニケーション条例を施行しました。条例を定めながら意思疎通支援事業の量を０のまま置くことはできません。**移動支援事業も、外出の困りごととして段差・公共交通・費用が挙げられている以上、０のままにはできません。**

第８期は、この４事業について、①使われなかった理由を確かめ、②施策（第２部）の手当てと対にして量を置きます。量だけを立てて施策がなければ、また０になります。

※ 見込量は、実績の推移だけでなく、今期アンケートの「今後利用したいサービス」「利用できない理由」、町内外の供給の制約、18 歳移行・65 歳移行、少人数で支援度の高いサービスの個別積上げを組み合わせて設定します。実績が０又は少人数のサービス（重度訪問介護、療養介護、地域移行支援・地域定着支援、居宅訪問型児童発達支援、医療的ケア児支援等）は、**０と見込む場合でも、その根拠と、必要が生じたときの対応を記載します。**

第３章　見込量確保のための方策

障害者総合支援法第 88 条第２項第２号及び児童福祉法第 33 条の 20 第２項第２号に基づく法定の記載事項です。見込量を確保するための方策を、次の５つに整理します。

1　町内の提供体制の確保

・事業所の参入促進、既存事業所の機能拡充。町内事業所の事業所番号と指定の種類は【町データ待ち】

2　広域連携による確保

・田村地方基幹相談支援センター、県中圏域、近隣市町村との連携。本町は町内に整備されていないサービスが多く、広域連携が前提となる

3　町外利用に伴う送迎・移動の支援

・町内に療育機関がなく町外通所となっている。移動支援事業・日中一時支援事業と接続させる（第２部第３章２）

4　人材の確保・定着と生産性向上

・障害者総合支援法第 88 条第３項第３号～第５号及び児童福祉法第 33 条の 20 第３項第３号（いずれも新設）に基づく。条文は「都道府県と連携した取組に関する事項」であり、町単独の取組ではなく県との連携を軸に書く。県の計画では同じ事項が義務とされ目標の定めも加わるため、県と同じ構えにしない

5　相談支援体制の確保

・相談支援専門員の確保、セルフプランからの移行。**成果目標⑤と同じ数値を用いる**

※ 4 は令和８年法律第 51 号により新たに加わった記載事項です（法第 88 条第３項第３号～第５号、児福法第 33 条の 20 第３項第３号。いずれも令和９年４月１日施行）。**障がい福祉計画の側には３つの号があるのに対し、障がい児福祉計画の側には地域生活支援事業に当たる号がなく、１つです。号の数が違うため、両者をまとめて１つに書きません。**

特定地域（中山間・人口減少地域）

令和９年４月１日から、「特定地域障害福祉サービス」の仕組みが設けられます（改正後の障害者総合支援法第 30 条第１項第３号。障がい児の通所支援は児童福祉法第 21 条の５の４第１項第３号の「特定地域通所支援」）。特定地域とは、「人口の減少その他の主務省令で定める基準に該当する地域として都道府県が定めるもの」をいいます。特定地域にある事業所は、指定障害福祉サービスの基準のうち都道府県の条例で定めるものを満たせば、サービスを提供できます。**人員の配置基準を地域の実情に応じて緩める仕組みであり、町内に整備されていないサービスが多い本町にとって、見込量を確保する方策の選択肢になります。**

国が示した基準の考え方（案）では、現行の特別地域加算等の対象地域は、全部指定・一部指定のいずれもすべて対象とされています。 本町は町全域が過疎地域（過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第２条第１項）であり、旧夏井村の区域は振興山村（山村振興法第７条第１項）です。いずれも特別地域加算等の対象地域に当たるため、**本町は町全域が特定地域の対象となる見込みです。**

ただし、基準は主務省令で定められ、指定は県が市町村の意向を踏まえて行います。対象となるサービスと人員配置基準も、障害福祉報酬改定の中で検討されています。 省令と県の方針が示された段階で、本町の意向を整理し、本章に反映します（【決定後に記載】）。

資料：第 160 回社会保障審議会障害者部会 資料２「障害福祉分野における特定地域（中山間・人口減少地域）の考え方について」（令和８年 10 月 20 日）。条文は e-Gov 法令 API（令和９年４月１日時点）で確認した。

第４部　計画の推進

１　推進体制

本計画は、町、**小野町自立支援協議会**、事業所連絡会、関係機関、住民の皆様の協働により推進します。

【表 34】第４部１　推進体制

主体	役割
町	計画の進行管理、サービスの支給決定、地域生活支援事業の実施、関係機関の調整
小野町自立支援協議会（支援協議会）	**計画の策定・変更に当たっての意見**、個別の事例を通じた地域の課題の共有と検討
基幹相談支援センター	総合的・専門的な相談支援、相談支援事業者への指導・助言、地域の相談支援体制の強化
事業所連絡会	事業所間の連携、人材の確保・育成
関係機関	県中保健所、特別支援学校、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、医療機関
住民	地域での理解と見守り、交流

２　支援会議・支援協議会の相互連携

令和８年法律第 51 号により、介護保険法第 115 条の 48 第５項と障害者総合支援法第 89 条の３第５項が新設されました（令和９年４月１日施行）。**両者は互いを名指しして、支援会議と支援協議会が相互に連携を図るよう努めることを定めています。**

本町では、**小野町自立支援協議会**と、高齢者分野の**支援会議**（介護保険法第 115 条の 48。改正により「会議」から名称が改まります）との連携を図ります。**65 歳到達時の移行、高齢障がい者、共生型サービスといった両分野にまたがる事柄を、ここで扱います。**

※ 条文が名指ししている会議体は２つではなく５つです。 障害者総合支援法第 89 条の３第５項（改正後）は、介護保険法第 115 条の 48 第１項の支援会議のほか、**社会福祉法第 106 条の３の２第１項の支援会議、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第 81 条第１項の支援協議会（居住支援協議会）、生活困窮者自立支援法第９条第１項の支援会議**、その他支援体制の構築に資する会議を挙げ、これらが組織され又は置かれているときは相互に連携を図るよう努めなければならないとしています。**同条は改正により全６項から全７項になります。** 本町に置かれている会議体を確かめたうえで、連携の場と頻度を定めます。

出所：障害者総合支援法（平成 17 年法律第 123 号）及び介護保険法（平成９年法律第 123 号）令和９年４月１日時点。e-Gov 法令 API（デジタル庁）により令和８年 10 月 19 日に取得。

（参考）小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業（令和９年４月１日新設）

令和９年４月１日に、社会福祉法第 106 条の６が「小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業」に差し替わります。小規模市町村とは、「その人口規模、その人口の減少の状況等からみて福祉サービスを提供する体制の確保に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる市町村として**厚生労働省令で定める基準**に該当するもの」をいいます（同条第１項）。該当する市町村は、この事業を**行うことができます**（任意）。

この事業は、障がい分野の事業を、高齢・子ども・生活困窮の各分野の事業と「一体のものとして実施する」ものです（同条第２項）。障がい分野からは次の２つが対象に入ります。

【表 35】第４部（参考）小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業（令和９年４月１日新設）

区分	障がい分野から対象となる事業	一体に行う相手方

相談（第２項第１号）	**障害者総合支援法第 77 条第１項第３号**（障がいのある人等からの相談に応じ、必要な情報の提供等を行う事業）	介護保険法第 115 条の 45 第２項第１号から第３号まで（地域包括支援センターの事業）／子ども・子育て支援法第 59 条第１号／生活困窮者自立支援法第３条第２項各号
地域づくり（第２項第３号）	**障害者総合支援法第 77 条第１項第９号**（創作的活動又は生産活動の機会の提供等＝地域活動支援センターに係る事業）	介護保険法第 115 条の 45 第１項第２号のうち厚生労働大臣が定めるもの／同条第２項第５号（生活支援体制整備事業）／子ども・子育て支援法第 59 条第９号

本町が小規模市町村に該当するかどうかは、厚生労働省令の基準によります（【町データ待ち】）。県に照会しています。**なお、基準を定める厚生労働省令は、令和８年 10 月 19 日現在、公布されていません**（社会福祉法施行規則を法令 API で確認。「小規模市町村」の語を含む条は１つもありません）。該当し、かつ本事業を行う場合は、**第３部第２章の地域生活支援事業（相談支援事業・地域活動支援センター機能強化事業）の実施体制が変わります。** 省令と県の方針が示された段階で改めて整理します。

※ 分野を超えて職員を配置できることが、この事業の実益です。 従事する職員及びその員数の基準は厚生労働省令で定められ、小規模市町村はこれに従うものとされます（同条第３項）。また、こども家庭センター、地域包括支援センター、**基幹相談支援センター**、生活困窮者自立支援法第３条第２項各号の事業を行う者その他の支援関係機関との緊密な連携を図るものとされ（同条第４項）、事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができます（同条第５項）。**※ 高齢者計画（第４章３）にも同じ内容を記載しています。**

出所：社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）令和９年４月１日時点。e-Gov 法令 API（デジタル庁）により令和８年 10 月 19 日に取得。改正の本体は社会福祉法等の一部を改正する法律（令和８年法律第 51 号。公布 令和８年６月 25 日）。

3　進行管理と評価

毎年度、成果目標の達成状況と活動指標・サービス見込量の実績を把握し、小野町自立支援協議会に報告します。**中間年（令和 10 年度）には、国・県の計画の改定や法改正への対応を含めて見直しを行います。**

4　計画の周知

計画の概要版を作成し、広報おのまち・防災無線・町公式ウェブサイトにより周知します。**障がいの特性に応じた届け方**を併せて用意します（第２部第４章３）。

資料編

1　計画の策定経過

策定の経過は【決定後に記載】です。

2　小野町自立支援協議会委員名簿

委員名簿は【決定後に記載】です。

3　パブリックコメントの結果

パブリックコメントの結果は【決定後に記載】です。

4　用語の説明

用語の説明は【決定後に記載】です。

5　関係法令

本計画の根拠となる法令は、第１部第１章２の表のとおりです。**令和８年法律第51号及び令和８年法律第77号による改正後の規定によります**（いずれも令和９年４月１日施行）。